Rechtliche Aspekte

Unterbringung, PsychKG Berlin und freiheitsbeschränkende Maßnahmen – nach Folien „Rechtliche Aspekte“, PsychKG-Broschüre und I care Kap. 7.5

Grundrechte · Freiheitsentziehung · BGB · PsychKG · StGB · SpDi · vorläufige Unterbringung · 3-Schritt-Methode · Zwangsbehandlung · Sicherungsmaßnahmen · Fixierung · richterliche Genehmigung · Betreuung · Patientenverfügung



INHALTE DIESES LERNHEFTS

- Freiheit, Freiheitsbeschränkung und -entziehung
- BGB, PsychKG und StGB
- PsychKG Berlin, SpDi, Krisendienst
- Ablauf einer Unterbringung
- Einwilligung und Zwangsbehandlung
- Isolierung und Fixierung
- Zulässigkeit von FbM
- Fixierung: Folgen und Alternativen
- Betreuung, Vollmacht, Patientenverfügung
- Pflichten bei Suizidgefahr, Übungsfragen 18–19

Quellen: M. Pahler, CE 11.3 Ausweglos? – Rechtliche Aspekte (Folien, BBG); BGSP/BIP: Das Berliner PsychKG – Informationen für Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige (2017); I care Pflege, Kap. 7.5 (Thieme 2020); BVerfG, Urteil vom 24.07.2018 (2 BvR 309/15, 502/16). Rechtsstand der Quellen beachten: Paragrafen des BGB wurden 2023 neu nummeriert. Keine Rechtsberatung. Abbildungen: eigene Zeichnungen.
Zusammenfassung für den persönlichen Lerngebrauch – Luca Maranta (LM) · P1 O 25.1

Inhaltsverzeichnis

Lernheft Rechtliche Aspekte · 12 Kapitel + Glossar

1 **Freiheit und ihre Einschränkung**
Grundrecht · Freiheitsbeschränkung · Freiheitsentziehung · Verhältnismäßigkeit

2 **Rechtliche Grundlagen der Unterbringung**
BGB · PsychKG · StGB (Übungsfrage 18)

3 **Das Berliner PsychKG und die Versorgung**
Grundsätze · §§ 1–2 · Pflichtversorgung · SpDi · Krisendienst · Beschwerde

4 **Unterbringung nach PsychKG**
Voraussetzungen · Zweck · Einrichtungen · Ablauf · Rechte · Entlassung

5 **Behandlung und Zwangsbehandlung**
Einwilligung · mutmaßlicher und natürlicher Wille · enge Voraussetzungen

6 **Besondere Sicherungsmaßnahmen**
§ 39 PsychKG · Isolierung · Fixierung · Urteil 2018

7 **Freiheitsbeschränkende Maßnahmen in der Pflege**
Formen · Zulässigkeit (Übungsfrage 19) · Zustimmung · richterliche Genehmigung

8 **Fixierung: Risiken, Alternativen, Pflege**
Folgen · Vermeidung · Pflege während und nach der Fixierung

9 **Betreuung, Vollmacht, Patientenverfügung**
Vertretung · Reform 2023 · Wille der Person zuerst

10 **Pflichten bei Suizidgefahr**
Maßnahmen (Wdh.) · unterlassene Hilfeleistung · Schweigepflicht · Dokumentation

11 **Psychiatrische Versorgungsangebote**
stationär bis ambulant · Fachbereiche

12 **Übungsfragen – Lösungen**
Fragen 18–19 aus dem Übungsblatt CE 11.3

A–Z **Glossar**
Fachbegriffe mit deutscher Übersetzung und Kurzerklärung

1 Freiheit und ihre Einschränkung

Grundrecht · Freiheitsbeschränkung · Freiheitsentziehung · Verhältnismäßigkeit

Die Freiheit der Person ist ein **Grundrecht** (Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz: „Die Freiheit der Person ist unverletzlich"). Über eine Freiheitsentziehung darf nur ein **Richter** entscheiden (Art. 104 GG). Jede Maßnahme gegen den Willen eines Menschen ist deshalb ein schwerer Eingriff und braucht eine gesetzliche Grundlage.

Freiheitsbeschränkung: Jemand wird **gegen seinen Willen** daran gehindert, einen bestimmten, für ihn an sich zugänglichen Ort aufzusuchen oder sich dort aufzuhalten.
Freiheitsentziehung: die **schwerste Form** der Freiheitsbeschränkung – die körperliche Bewegungsfreiheit wird **nach jeder Richtung** aufgehoben.

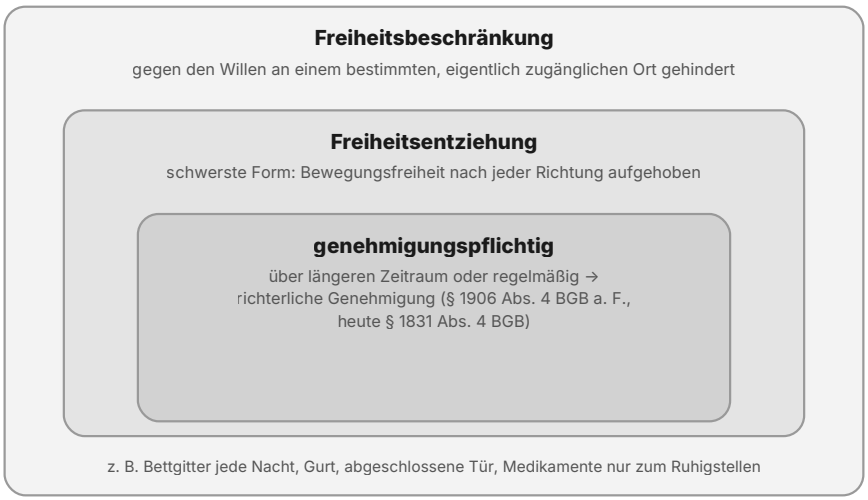


Abb. 1 Freiheitsbeschränkung, Freiheitsentziehung und genehmigungspflichtige Maßnahmen – ineinander geschachtelt.

Die strengste Form sind **freiheitsentziehende und genehmigungspflichtige Maßnahmen** (Folie: § 1906 Abs. 4 BGB; seit 2023: § 1831 Abs. 4 BGB). Sie liegen vor, wenn einer pflegebedürftigen Person **über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig** die Freiheit entzogen wird.

MERKE

Verhältnismäßigkeit: Jede Einschränkung muss geeignet, erforderlich und angemessen sein. Es gilt immer das **mildeste wirksame Mittel** – so kurz wie möglich, so wenig wie nötig. Juristisch unbedenklich ist eine Maßnahme nur, wenn die einwilligungsfähige Person selbst zustimmt.

KURZ GEFRAGT

1. Was ist der Unterschied zwischen Freiheitsbeschränkung und Freiheitsentziehung?
2. Wann ist eine freiheitsentziehende Maßnahme genehmigungspflichtig?

Lösung: 1. Beschränkung: an einem bestimmten Ort gehindert; Entziehung: Bewegungsfreiheit nach jeder Richtung aufgehoben (schwerste Form) · 2. wenn sie über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig erfolgt

2 Rechtliche Grundlagen der Unterbringung

BGB · PsychKG · StGB (Übungsfrage 18)

Eine Unterbringung oder Zwangseinweisung gegen den Willen ist ein **Eingriff in die Grundrechte**. Sie ist nur auf drei rechtlichen Wegen möglich:



Abb. 2 Drei rechtliche Grundlagen für eine Unterbringung gegen den Willen.

Grundlage	Voraussetzung	Wann typisch?
zivilrechtlich: BGB, Betreuungsrecht	**Selbstgefährdung** (Gefahr, sich zu töten oder erheblich gesundheitlich zu schaden) oder **notwendige Heilbehandlung**, die die Person krankheitsbedingt nicht einsieht. Betreuer*in entscheidet, Betreuungsgericht genehmigt.	wenn bereits eine Betreuung besteht oder eingerichtet werden sollte
öffentlich-rechtlich: Unterbringungsgesetz der Länder – in Berlin PsychKG (2016)	gegenwärtige, erhebliche **Selbst- oder Fremdgefährdung** aufgrund einer psychischen Erkrankung, die nicht anders abwendbar ist	meist in der Psychiatrie, v. a. wenn **keine Betreuung** besteht
strafrechtlich: StGB	Person hat eine **Straftat** begangen und ist psychisch krank	Maßregelvollzug in der **Forensik**

BEISPIEL AUS I CARE

Frau L., 22, wird nach einem Suizidversuch in der Klinik untersucht. Der Psychiater stellt weiter bestehende Suizidalität fest und schlägt die Aufnahme auf eine geschützte Station vor. Frau L. lehnt ab und sagt, sie wolle sich nicht mehr das Leben nehmen. Der Psychiater hält das nicht für glaubhaft – ein Gericht entscheidet und ordnet die Unterbringung an.

3 Das Berliner PsychKG und die Versorgung

Grundsätze · §§ 1–2 · Pflichtversorgung · SpDi · Krisendienst · Beschwerde

Das Berliner „Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten“ (PsychKG) gilt seit **29. Juni 2016**. Es regelt drei Bereiche: **Hilfen** für psychisch erkrankte Menschen, die **öffentlich-rechtliche Unterbringung** zur Gefahrenabwehr und die **strafrechtsbezogene Unterbringung**.

Grundsätze (Folie)

- **Freiheitsrechte und Autonomie** haben hohen Stellenwert
- Unterbringung, Zwangsbehandlung und Wiedereingliederung werden **getrennt** geregelt
- **Aufklärung** der Patient*innen ist vorgeschrieben
- **Dokumentation** aller Maßnahmen ist wichtig

§ 1 – Hilfen sollen …

- Erkrankung heilen, Verschlimmerung verhüten
- Beschwerden lindern
- gesellschaftlicher Ausgrenzung entgegenwirken
- soziale Wiedereingliederung ermöglichen
- **Unterbringung vermeiden**

§ 2 – Fürsorgegrundsatz

- individuelle Situation und besondere Bedürfnisse
- **Würde** und persönliche Integrität
- Autonomie, Entscheidungsfreiheit, Unabhängigkeit
- Einschränkungen unterliegen der **Verhältnismäßigkeit**

Ambulant vor stationär (§ 4)

Vorsorgende Hilfe soll eine stationäre Behandlung möglichst vermeiden. Wünsche der Betroffenen sind zu berücksichtigen; auch Angehörige haben Anspruch auf Beratung.

Psychiatrische Pflichtversorgung

Versorgungsregion ist der **Bezirk**. Kliniken mit Pflichtversorgung arbeiten eng mit dem SpDi, ambulanten Psychiater*innen und psychiatrischen Einrichtungen zusammen – **wohnortnah**, keine Einrichtungen mehr außerhalb der Stadtgrenze. Niedrigschwellige Angebote: **Kontakt- und Beratungsstellen**, Suchtberatung, Beschäftigungsangebote, Wohneinrichtungen und der **Berliner Krisendienst**.

Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi)	Aufgaben
in jedem Berliner Bezirk, geleitet von einer Fachärztin/einem Facharzt für Psychiatrie; multiprofessionelles Team (Psychiatrie, Psychologie, Sozialarbeit, Verwaltung)	• Beratung und psychosoziale Unterstützung, Koordination von Hilfen • **Hausbesuche** (mit Einwilligung) • gutachterliche Stellungnahmen • koordiniert Schutz bei Eigen- und Fremdgefährdung • kann bei gewichtigen Anzeichen eine Vorführung zur ärztlichen Untersuchung mit Hilfe der Polizei veranlassen • **Unterbringungsanordnungen** nach PsychKG und **schriftlicher Antrag an das Gericht**

BESCHWERDE UND KONTROLLE

Beschwerde- und Informationsstelle Psychiatrie (BIP) für das ganze Versorgungssystem, **Patientenfürsprecher*innen** im jeweiligen Krankenhaus, ehrenamtliche **Besuchskommissionen** prüfen jährlich die Einrichtungen. Die Fachaufsicht über Unterbringungen liegt beim Bezirksamt (Amtsärzt*in).

4 Unterbringung nach PsychKG

Voraussetzungen · Zweck · Einrichtungen · Ablauf · Rechte · Entlassung

Voraussetzungen (§ 15) und Zweck (§ 16)

- Durch krankheitsbedingtes Verhalten besteht eine **gegenwärtige und erhebliche Gefahr** für das eigene Leben oder die Gesundheit (**Selbstgefährdung**) oder für bedeutende Rechtsgüter Dritter (**Fremdgefährdung**).
- Die Gefahr kann **nur durch die Unterbringung** abgewehrt werden.
- **Fehlende Behandlungsbereitschaft allein** rechtfertigt keine Unterbringung.
- Zweck: **Abwehr der Gefahr** sowie Heilung, Besserung, Linderung oder Verhütung einer Verschlimmerung.

Unterbringung bedeutet: gegen den Willen in eine Einrichtung eingewiesen oder **am Verlassen gehindert**. Wer eine **Freiwilligkeitserklärung** unterschreibt, wird nicht per Beschluss untergebracht – und kann freiwillig wieder gehen; nach einem Widerruf wird neu ärztlich geprüft.

Einrichtungen und ihre Pflichten

Einrichtungen mit von der Senatsverwaltung verliehener **hoheitlicher Gewalt**: psychiatrische Krankenhäuser, psychiatrische Fachabteilungen in Krankenhäusern, geeignete Heime (in Berlin bisher nur Krankenhäuser).

- Fachpersonal in ausreichender Zahl
- wissenschaftlich anerkannte Behandlung
- **gesicherte Ausgänge und Freiflächen**, täglicher Aufenthalt im Freien
- Kinder/Jugendliche getrennt von Erwachsenen

Ablauf

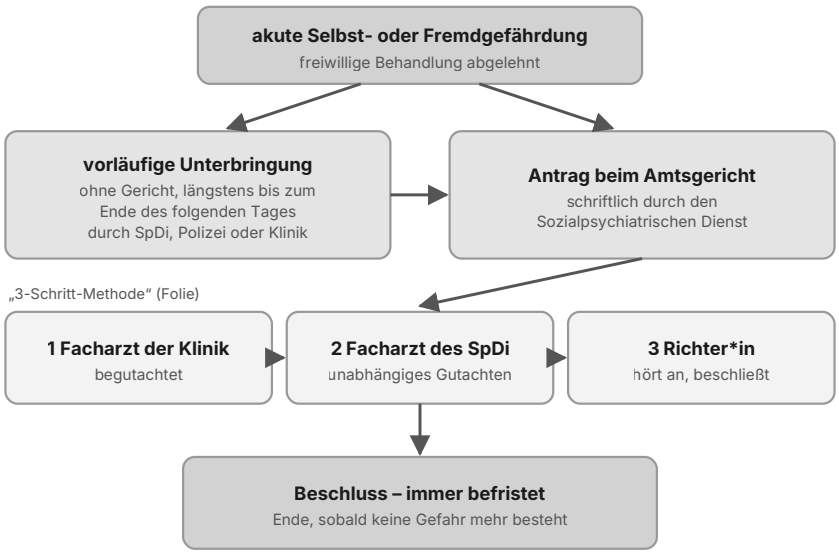


Abb. 3 Ablauf einer Unterbringung nach dem Berliner PsychKG mit der „3-Schritt-Methode“ der Folie.

Schritt	Inhalt
Antrag (§ 22)	schriftlich durch den **SpDi** (bei Kindern/Jugendlichen den KJPD) an das zuständige **Amtsgericht**
vorläufige Unterbringung (§ 23)	wenn ein Beschluss nicht rechtzeitig möglich ist: Anordnung durch den SpDi; wenn auch das nicht rechtzeitig geht, durch **Polizei** oder **Klinik** (nach ärztlicher Prüfung). Dauer längstens **bis zum Ablauf des folgenden Tages** (Broschüre: „48-Stunden-Regel“; Folie: 24 Stunden).
Begutachtung	1. Facharzt der Klinik · 2. Facharzt des SpDi (unabhängig) · 3. **Amtsrichter*in** hört an und beschließt
Beschluss	immer **befristet**; Ende, sobald keine Gefahr mehr besteht

Rechte der untergebrachten Person (Auswahl)

- **Aufklärung** bei Aufnahme über Rechte, Pflichten, Rechtsschutz und Beschwerde (dokumentiert, ärztlich unterschrieben)
- Gelegenheit, eine **Vertrauensperson** zu benachrichtigen; Betreuer*in wird informiert
- **Behandlungsplan** zeitnah, besprochen mit der Person
- Recht auf Besuch, Post (ungeöffnet), Telefon, persönliche Gegenstände, Religionsausübung – Einschränkung nur ärztlich angeordnet bei erheblicher Gefahr
- Unterbringung möglichst bald in **offener Form**; Akteneinsicht

ENTLASSUNG – RECHENBEISPIEL DER FOLIE

Eine Unterbringung endet um **24 Uhr des letzten Tages**. Beispiel: 14-tägige Unterbringung vom 27.10. bis 10.11.2026 → Ende am 10.11.2026 um 24:00 Uhr. Praktischer ist die Entlassung am 11.11. nach dem Frühstück – mit Einverständnis der Person, die dann freiwillig bleibt. (Die Folie schreibt im Beispiel einmal „2021" – gemeint ist 2026.)

KURZ GEFRAGT

1. Welche zwei Voraussetzungen nennt die Folie für eine Unterbringung?
2. Wer stellt den Antrag, wer entscheidet?
3. Wer darf eine vorläufige Unterbringung anordnen?

Lösung: 1. krankheitsbedingte gegenwärtige, erhebliche Gefahr; Gefahr nur durch Unterbringung abwendbar · 2. SpDi stellt den Antrag, das Amtsgericht entscheidet · 3. SpDi, Polizei oder Klinik (jeweils nach ärztlicher Prüfung)

5 Behandlung und Zwangsbehandlung

Einwilligung · mutmaßlicher und natürlicher Wille · enge Voraussetzungen

- Untergebrachte Menschen haben **Anspruch auf Behandlung** ihrer Anlasserkrankung.
- **Jede Behandlung braucht eine Einwilligung** – auch während einer Unterbringung.
- Ist die Person nicht **einwilligungsfähig** und hat keine Vertretung, wird eine **Betreuung angeregt**.
- Bei bestehender Betreuung oder Patientenverfügung zählt der **mutmaßliche Wille**: Was würde die Person ohne die aktuelle Beeinträchtigung wollen? Auch eine Ablehnung im **natürlichen Willen** oder in einer Patientenverfügung ist zu berücksichtigen.

Zwangsbehandlung (§ 28 Abs. 6)

Nur möglich, wenn die Person ihre Chance auf Besserung krankheitsbedingt nicht erkennen kann – mit dem Ziel, die **Einwilligungsfähigkeit wiederherzustellen**. Alle Bedingungen müssen erfüllt sein:

1. mildere Behandlungen waren erfolglos
2. ernsthafter Versuch, eine Einwilligung zu erreichen
3. verständliche ärztliche Aufklärung
4. Nutzen überwiegt deutlich die Belastung
5. ärztliche Anordnung, Überwachung festgelegt
6. Art und Dauer begrenzt
7. **vorherige Zustimmung des Betreuungsgerichts**
8. Abbruch, wenn nicht mehr verhältnismäßig
9. Nachbesprechung, Aufklärung über Rechte, Dokumentation

Notfall (§ 28 Abs. 7): Bei Lebensgefahr ist eine Behandlung gegen den Willen möglich, wenn keine wirksame Patientenverfügung entgegensteht, Sicherungsmaßnahmen nicht reichen und die Person nicht einwilligungsfähig ist. Für die Weiterbehandlung ist unverzüglich das Gericht einzuschalten.

6 Besondere Sicherungsmaßnahmen

§ 39 PsychKG · Isolierung · Fixierung · Urteil 2018

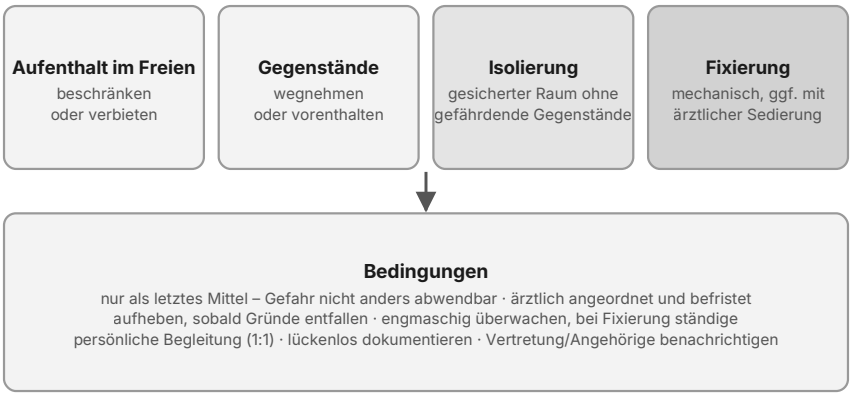


Abb. 4 Besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 39 PsychKG Berlin und ihre Bedingungen.

Zulässig, wenn die Gefahr besteht, dass sich die untergebrachte Person **selbst tötet oder ernsthaft verletzt**, gewalttätig wird, Dritte schädigt oder die Einrichtung ohne Erlaubnis verlassen will – und diese Gefahr **nicht anders abgewendet** werden kann.

- Anordnung nur durch **Ärzt*in**, **befristet**, aufheben sobald die Gründe entfallen
- Isolierung und Fixierung werden von Fachpersonal überwacht; bei Fixierung **ständige persönliche Begleitung**
- Rechtliche Vertretung oder Angehörige werden benachrichtigt; alles wird mit Gründen **dokumentiert** (§ 82)

URTEIL 2018

Das **Bundesverfassungsgericht** hat am 24.07.2018 entschieden: Eine **5- oder 7-Punkt-Fixierung**, die **länger als etwa eine halbe Stunde** dauert, ist eine Freiheitsentziehung und braucht eine **richterliche Genehmigung**; während der Fixierung ist eine **1:1-Betreuung** durch Fach- oder Pflegepersonal nötig; danach ist auf die Möglichkeit hinzuweisen, die Maßnahme gerichtlich überprüfen zu lassen. Die Broschüre von 2017 nennt noch 18 Stunden – dieser Stand ist überholt.

7 Freiheitsbeschränkende Maßnahmen in der Pflege

Formen · Zulässigkeit (Übungsfrage 19) · Zustimmung · richterliche Genehmigung

Formen

Form	Beispiele
Unterbringung	gegen den Willen an einen anderen Ort gebracht, z. B. Heim, Psychiatrie
mechanische Fixierung	Bettseitenteile, eingespannte Laken, Gurte, Stecktisch am Rollstuhl, abgeschlossene Tür
medikamentöse Fixierung	Schlaf- oder Beruhigungsmittel, **nur um ruhigzustellen**. Müdigkeit als Nebenwirkung einer Therapie zählt nicht.

Zulässigkeit (Übungsfrage 19)

Freiheitsbeschränkende Maßnahmen sind **nur zum Wohl** der Bewohner*innen/Patient*innen zulässig bei:

1. krankheits- oder behinderungsbedingter **Gefahr einer Selbsttötung**
2. drohender **erheblicher Gesundheitsschädigung**
3. notwendiger **Untersuchung, Heilbehandlung oder ärztlichem Eingriff**, deren Sinn die Person krankheitsbedingt nicht einsieht
4. in Ausnahmefällen, bei der öffentlich-rechtlichen Unterbringung: **Schutz Dritter**

Immer prüfen: Kann sich die Person selbst äußern? Gibt es **Alternativen**, die die Bewegungsfreiheit weniger einschränken?

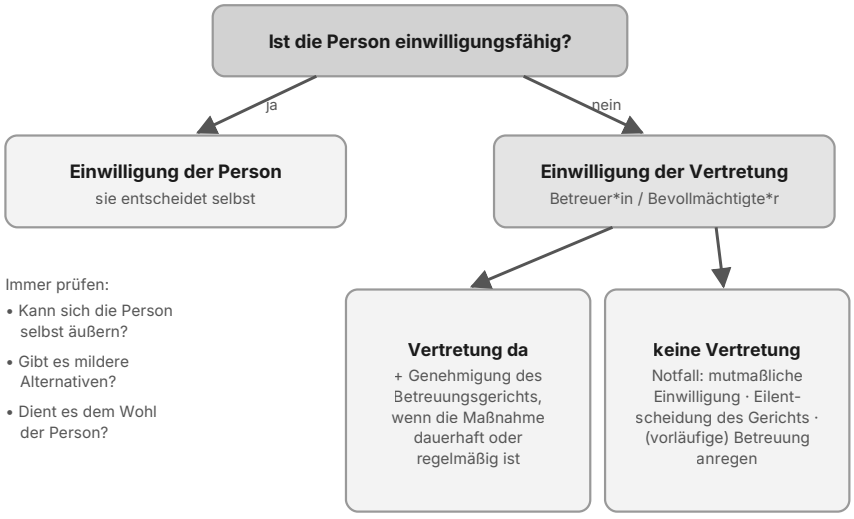


Abb. 5 Wer muss zustimmen? Entscheidungsweg nach I care, Abb. 7.5 (nach Hell 2018).

Richterliche Genehmigung

- nötig, wenn die Maßnahme **über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig** erfolgt
- **regelmäßig** = immer zur gleichen Zeit oder aus dem gleichen Anlass (z. B. jeden Abend die Tür abschließen)
- **längerer Zeitraum** kann schon ein Tag oder eine Nacht sein; bei 5-/7-Punkt-Fixierung über **30 Minuten**
- Auch eine **Vorsorgevollmacht** ersetzt die richterliche Genehmigung nicht (BVerfG 2015).
- **Kinder**: Seit 1.10.2017 brauchen Eltern zusätzlich eine **familiengerichtliche Genehmigung**, wenn das Kind in einer Einrichtung ist (§ 1631b BGB).

- Im **Notfall** dürfen Pflegende fixieren (nicht medikamentös), müssen aber sofort eine Ärztin/einen Arzt verständigen.

8 Fixierung: Risiken, Alternativen, Pflege

Folgen · Vermeidung · Pflege während und nach der Fixierung

Der **Nutzen von Fixierungen ist nicht belegt, ein Schaden sehr wahrscheinlich** (I care). Fixierungen senken die Sturzgefahr nicht – sie erhöhen sie. Und sie erleichtern die Arbeit nicht: Korrekt durchgeführt bedeuten sie viel Beobachtung, Dokumentation und Prophylaxe.

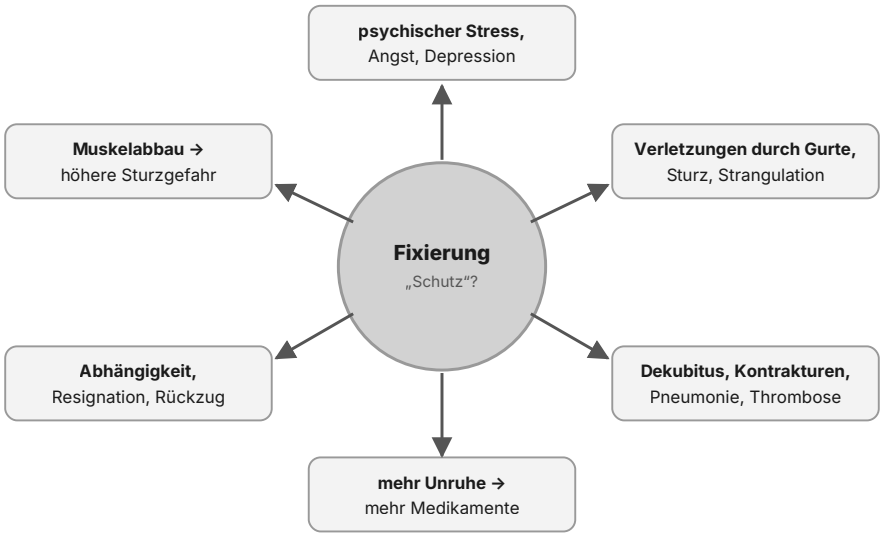


Abb. 6 Negative Auswirkungen von Fixierungen (nach I care, Abb. 7.4).

Alternativen

- **Verhalten hinterfragen**, körperliche Ursachen suchen (Schmerz, Infekt, Harndrang, Delir)
- Medikation überprüfen
- Deeskalation, Gespräch, Präsenz
- Sturzprophylaxe: Hüftprotektoren, feste Schuhe, frühe Mobilisation
- **Niederflurbett**, Sensormatte, geteilte Bettseitenteile
- Licht, Stolperfallen beseitigen, Klingel erreichbar
- Bezugspersonen, Fallbesprechungen

Pflege während der Fixierung

- **ärztliche Anordnung** (im Notfall sofort einholen)
- nach gefährlichen Gegenständen durchsuchen, nur wenn nötig entkleiden
- sachgerecht anlegen; **Durchblutung, Motorik, Sensibilität** kontrollieren
- **kontinuierliche 1:1-Überwachung** bei 5-/7-Punkt-Fixierung
- Prophylaxen (Dekubitus, Thrombose, Pneumonie)
- ernst nehmen, beruhigend kommunizieren
- jeden Schritt und die auslösende Situation **dokumentieren**
- prüfen, ob gelockert/beendet werden kann; **Nachbesprechung**; Hinweis auf gerichtliche Überprüfung

> **MERKE**
>
> Freiheitsbeschränkende Maßnahmen **nie „zur Erleichterung" der Pflege**. Sie müssen dem Schutz dienen, fachlich begründet, so mild wie möglich, **zeitlich begrenzt** und mit allen Beteiligten abgestimmt sein; der Nutzen muss den Schaden überwiegen.

KURZ GEFRAGT

1. Nenne drei Folgen einer Fixierung.
2. Was wird bei fixierten Patient*innen regelmäßig kontrolliert?
3. Nenne drei Alternativen zum Bettgitter.

Lösung: 1. z. B. Dekubitus, Kontrakturen, Thrombose, Sturz-/Strangulationsgefahr, Angst, Resignation · 2. Durchblutung, Motorik, Sensibilität, Befinden – bei 5-/7-Punkt 1:1 · 3. z. B. Niederflurbett, Sensormatte, Hüftprotektoren, geteilte Seitenteile

9 Betreuung, Vollmacht, Patientenverfügung

Vertretung · Reform 2023 · Wille der Person zuerst

Begriff	Bedeutung	BGB vor 2023 → seit 2023
Betreuung	vom Betreuungsgericht bestellte **rechtliche Vertretung** eines Volljährigen für bestimmte Aufgabenkreise (z. B. Gesundheit, Aufenthalt, Vermögen); steht auf dem Betreuerausweis	§ 1896 → § 1814
Vorsorgevollmacht	selbst bestimmte **Vertrauensperson** entscheidet ohne Gericht in festgelegten Bereichen	–
Patientenverfügung	schriftliche, selbst unterschriebene Festlegung von Behandlungswünschen; **bindend**	§ 1901a → § 1827
Unterbringung, FeM	Genehmigung durch das Betreuungsgericht	§ 1906 → § 1831
ärztliche Zwangsmaßnahme	nur unter engen Voraussetzungen mit Genehmigung	§ 1906a → § 1832

MERKE

Die betroffene Person wird **immer zuerst selbst gefragt** – erst dann die Betreuung, und nur in deren Aufgabenkreis. Die Betreuung entscheidet zum **Wohl und nach den Wünschen** der betreuten Person, nicht nach eigenem Geschmack. Angehörige sind ohne Vollmacht oder Betreuung **keine rechtliche Vertretung**.

Hinweis: Folien und I care (2020) nennen die alten Paragrafen. Seit der Betreuungsrechtsreform am 1.1.2023 gelten die neuen Nummern; neu ist außerdem ein befristetes Notvertretungsrecht für Ehegatten in Gesundheitsfragen (§ 1358 BGB).

10 Pflichten bei Suizidgefahr

Maßnahmen (Wdh.) · unterlassene Hilfeleistung · Schweigepflicht · Dokumentation

Pflegerische Maßnahmen bei möglichen Suizidabsichten (Folie, Wdh.)

- Suizidabsichten **erkennen**; offen und einfühlsam **ansprechen**, Gespräche immer wieder anbieten
- **regelmäßige und engmaschige Sichtkontrollen**
- Absprachen treffen, **Antisuizidpakt** vereinbaren (auch nur mündlich mit der Pflegeperson möglich, danach im Pflegebericht festhalten)
- Sicherheit schaffen durch **Zimmerkontrollen**
- Kolleg*innen und Ärzt*in informieren – **auch schriftlich**

Rechtsgebiet	Was heißt das für die Pflege?
Unterlassene Hilfeleistung (§ 323c StGB)	Wer bei einem Unglücksfall nicht hilft, obwohl Hilfe **erforderlich und zumutbar** ist, macht sich strafbar. Zumutbar ist für Pflegende immer: Hilfe holen (Ärzt*in, Notruf 112) und Erste Hilfe leisten. Ein geäußerter Suizidwunsch verpflichtet zu reagieren.
Schweigepflicht (§ 203 StGB)	gilt gegenüber allen, die nicht an der Behandlung beteiligt sind – auch Angehörigen am Telefon. Informationen im **Behandlungsteam** weitergeben ist nötig und erlaubt.
Dokumentation	Gespräche, Absprachen, Beobachtungen, Maßnahmen und deren Gründe nachvollziehbar dokumentieren – gerichtliche Verfahren „stehen und fallen" mit der Dokumentation.

11 Psychiatrische Versorgungsangebote

stationär bis ambulant · Fachbereiche

- stationär, teilstationär, **Tagesklinik**
- ambulante psychiatrische Versorgung (z. B. Institutsambulanz, niedergelassene Psychiater*innen)
- Allgemeinpsychiatrie
- Gerontopsychiatrie
- Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Forensik (Maßregelvollzug)
- **Betreutes Wohnen**, Wohneinrichtungen
- Kontakt- und Beratungsstellen, Krisendienst, SpDi

Arbeitsauftrag der Folie: Recherchiere, welche Angebote psychiatrischer Versorgung es in deinem Bezirk gibt.

12 Übungsfragen – Lösungen

Fragen 18–19 aus dem Übungsblatt CE 11.3

Frage	Lösung
18. Nennen Sie die rechtlichen Grundlagen, die eine Unterbringung/ Zwangseinweisung ermöglichen.	**Zivilrechtlich** nach dem BGB (Betreuungsrecht): bei Selbstgefährdung oder notwendiger Heilbehandlung, beantragt durch Betreuer*in, genehmigt durch das Betreuungsgericht (früher § 1906, heute § 1831 BGB). **Öffentlich-rechtlich** nach dem Unterbringungsgesetz des Landes – in Berlin das **PsychKG** (2016): bei gegenwärtiger, erheblicher Selbst- oder Fremdgefährdung infolge psychischer Erkrankung; Antrag durch den SpDi, Entscheidung durch das Amtsgericht; vorläufig auch durch SpDi, Polizei oder Klinik. **Strafrechtlich** nach dem **StGB**: bei psychisch kranken Menschen, die eine Straftat begangen haben → Forensik.
19. Wann kann eine Zulässigkeit von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen indiziert sein?	Nur zum **Wohl** der Person: 1. bei krankheits- oder behinderungsbedingter **Gefahr einer Selbsttötung**, 2. um eine **erhebliche Gesundheitsschädigung** abzuwenden, 3. wenn eine **Untersuchung, Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff** notwendig ist, dessen Sinn die Person krankheitsbedingt nicht einsieht, 4. ausnahmsweise bei öffentlich-rechtlicher Unterbringung zum **Schutz Dritter**. Dazu: kein milderes Mittel möglich, Einwilligung der Person oder ihrer Vertretung, bei längerer oder regelmäßiger Maßnahme **richterliche Genehmigung**, ärztliche Anordnung, befristet, überwacht und dokumentiert.

Glossar

Fachwort · deutscher Begriff · Kurzerklärung

Fachwort	Deutscher Begriff
Amtsgericht	zuständiges Gericht Entscheidet als Betreuungsgericht über Unterbringungen und genehmigungspflichtige Maßnahmen.
Besondere Sicherungsmaßnahmen	Schutzmaßnahmen nach § 39 PsychKG Einschränkung des Aufenthalts im Freien, Wegnahme von Gegenständen, Isolierung oder Fixierung – nur als letztes Mittel.
Betreuung	rechtliche Vertretung Volljähriger Vom Gericht bestellte Vertretung für bestimmte Aufgabenkreise, wenn jemand seine Angelegenheiten nicht selbst regeln kann.
Einwilligungsfähigkeit	Fähigkeit zuzustimmen Die Person kann Art, Bedeutung und Tragweite einer Maßnahme verstehen und danach entscheiden.
Fixierung	Festbinden Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch Gurte oder andere mechanische Vorrichtungen.
Forensik	Maßregelvollzug Psychiatrische Klinik für psychisch kranke Menschen, die eine Straftat begangen haben.
Freiheitsbeschränkung	Einschränkung der Bewegungsfreiheit Jemand wird gegen seinen Willen gehindert, einen eigentlich zugänglichen Ort aufzusuchen oder sich dort aufzuhalten.
Freiheitsentziehung	Aufhebung der Bewegungsfreiheit Schwerste Form der Freiheitsbeschränkung: Bewegungsfreiheit nach jeder Richtung aufgehoben.
Isolierung	Unterbringung im gesicherten Raum Aufenthalt in einem besonders gesicherten Raum ohne gefährdende Gegenstände.
Medikamentöse Fixierung	Ruhigstellen durch Medikamente Gabe von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln allein, um jemanden ruhigzustellen – gilt als freiheitsbeschränkend.
Mutmaßlicher Wille	vermuteter Wille Das, was die Person ohne ihre aktuelle Beeinträchtigung wollen würde.
Natürlicher Wille	aktuell geäußerter Wille Wille, den eine Person in der konkreten Situation zeigt – auch wenn sie nicht einwilligungsfähig ist.
Patientenverfügung	schriftliche Behandlungswünsche Vorab festgelegte, verbindliche Erklärung, welche Behandlungen jemand will oder ablehnt.
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz Landesgesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; in Berlin seit 2016.
Sozialpsychiatrischer Dienst	SpDi Bezirklicher Dienst unter fachärztlicher Leitung: Beratung, Hausbesuche, Hilfe in Krisen, Antrag auf Unterbringung.
Unterlassene Hilfeleistung	§ 323c StGB Strafbar ist, wer bei einem Unglücksfall nicht hilft, obwohl Hilfe erforderlich und zumutbar ist.

Fachwort	Deutscher Begriff
Verhältnismäßigkeit	Angemessenheit Ein Eingriff muss geeignet, erforderlich und angemessen sein – das mildeste wirksame Mittel wählen.
Vorläufige Unterbringung	Unterbringung ohne Gerichtsbeschluss Im Eilfall durch SpDi, Polizei oder Klinik – längstens bis zum Ende des folgenden Tages.
Vorsorgevollmacht	Vollmacht für den Ernstfall Bestimmt eine Vertrauensperson, die ohne Gericht bestimmte Entscheidungen treffen darf.
Zwangsbehandlung	Behandlung gegen den Willen Nur unter engen Voraussetzungen und mit Zustimmung des Betreuungsgerichts erlaubt.

Quellen: Folien M. Pahler (BBG) · BGSP/BIP PsychKG-Broschüre 2017 · I care Pflege Kap. 7.5 · BVerfG 2018.